

Manejo de intoxicaciones en la Unidad de Observación de Urgencias

ISRS AINE antidepresivos tricíclicos benzodiazepinas pregabalina

Propuesta de protocolo asistencial para pacientes adultos

Documento operativo para apoyar la selección, vigilancia, tratamiento y disposición de pacientes con intoxicación aguda. Los tiempos indicados son mínimos orientativos y deben individualizarse según sustancia concreta, dosis, formulación, hora fiable de ingesta, coingestas, comorbilidad y evolución clínica.

Versión 1.0 | Septiembre de 2026

Advertencia clínica

Este documento no sustituye la valoración toxicológica individual ni los protocolos institucionales. Ante dosis potencialmente grave, incertidumbre relevante o evolución atípica, consultar al Servicio de Información Toxicológica de España 91 562 04 20, disponible 24 horas, y priorizar un nivel asistencial superior.

Resumen ejecutivo

Grupo	Observación mínima si asintomático y bajo riesgo	Monitorización clave
ISRS no citalopram ni escitalopram	6 h desde la ingesta; 12 h si ingesta incierta, gran dosis, síntomas leves o coingesta	Constantes y nivel de conciencia; ECG inicial. Telemetría si QTc alterado, citalopram/escitalopram o síntomas.
Citalopram o escitalopram	12 h como mínimo; ampliar a 24 h si gran dosis, QTc prolongado, bradicardia, síntomas o coingesta cardiotóxica	Telemetría, ECG seriado, K, Mg y Ca.
AINE liberación inmediata	4–6 h; 12 h si formulación retardada, dosis importante o síntomas	Constantes; función renal, electrolitos y gasometría si ingesta relevante/síntomas.
Antidepresivos tricíclicos	6 h solo si permanece asintomático y ECG normal; toxicidad clínica o ECG anormal excluye observación convencional	Telemetría continua, ECG seriado, QRS, QTc y aVR; vigilancia neurológica estrecha.
Benzodiazepinas aisladas	6 h o hasta recuperación clínica completa; 12–24 h si acción larga, edad avanzada, hepatopatía, síntomas persistentes o coingesta	Nivel de conciencia, FR y SpO ₂ ; capnografía si somnolencia moderada/profunda.
Pregabalina aislada	6 h si asintomático; 12 h si síntomas, gran dosis o tiempo incierto; 24 h o ingreso si deterioro persistente/IR	Nivel de conciencia, FR, SpO ₂ ; capnografía si sedación; función renal.

1 Objetivo y alcance

Estandarizar el manejo de adultos con exposición aguda a los cinco grupos farmacológicos indicados, desde la valoración inicial hasta el alta, ingreso o traslado a un área de críticos. Se aplica a la Unidad de Observación de Urgencias y requiere adaptación a los recursos del centro.

2 Definiciones operativas

- Tiempo de observación: se cuenta desde la hora de ingesta fiable. Si es desconocida, desde la llegada, con ampliación según farmacocinética y clínica.
- Asintomático: constantes estables, Glasgow 15, marcha y habla basales, sin hallazgos neurológicos, respiratorios, hemodinámicos ni electrocardiográficos relevantes.
- Monitorización clínica: reevaluación protocolizada de constantes, estado mental, pupilas, habla, marcha, vómitos, diuresis y aparición de toxíndromes.
- Telemetría: vigilancia continua del ritmo; no equivale a ECG de 12 derivaciones ni sustituye su repetición cuando esté indicada.
- Gran dosis: dosis por encima del umbral local de riesgo, dosis desconocida con envases vacíos o una cantidad capaz de causar toxicidad grave. Debe confirmarse con toxicología clínica/SIT.

3 Criterios de ubicación

3.1 Aptos para Unidad de Observación

- Vía aérea protegida, ventilación adecuada y estabilidad hemodinámica.
- Toxicidad ausente o leve, con evolución estable y necesidades previsibles cubiertas por la unidad.
- ECG sin alteraciones de alto riesgo cuando la sustancia pueda producir cardiotoxicidad.
- Posibilidad de reevaluación médica inmediata, monitorización indicada y traslado rápido a críticos.
- Plan de valoración de riesgo suicida y seguridad antes del alta en ingestas intencionales.

3.2 Exclusión de observación convencional

Hallazgo	Destino o actuación
GCS < 9, pérdida de reflejos protectores, hipoventilación, hipoxemia o aspiración	Área de críticos; soporte de vía aérea y ventilación.
Convulsiones, delirium grave, agitación no controlable, hipertermia o síndrome serotoninérgico moderado/grave	Críticos/UCI según evolución.
Hipotensión persistente, arritmia, síncope cardiogénico o necesidad de vasopresor	Críticos/UCI.
QRS $\geq$ 100 ms en posible tricíclico; arritmia ventricular; patrón Brugada; QTc marcadamente prolongado	Tratamiento inmediato y críticos/UCI.
Acidosis metabólica significativa, lesión renal aguda, alteración electrolítica relevante o hemorragia digestiva	Ingreso según gravedad.
Coingesta de opioides, alcoholes tóxicos, paracetamol en dosis tóxica, cardiotóxicos u otra sustancia de cinética prolongada	Aplicar el protocolo de la sustancia de mayor riesgo.

4 Valoración inicial y medidas comunes

1. ABCDE, glucemia capilar inmediata, temperatura y acceso venoso. Oxígeno solo si hipoxemia; soporte ventilatorio precoz cuando proceda.
2. Historia dirigida: fármaco exacto, dosis máxima posible, formulación inmediata o retardada, hora, coingestas, tratamientos habituales, peso, función renal/hepática y motivo de la exposición.
3. Exploración seriada: Glasgow, pupilas, clonus/hiperreflexia, rigidez, signos anticolinérgicos, frecuencia respiratoria, perfusión, dolor abdominal y diuresis.
4. ECG de 12 derivaciones inicial en ingesta intencional o dosis relevante; medir PR, QRS y QTc y valorar R terminal en aVR. Repetir según el grupo y la evolución.
5. Analítica dirigida, evitando paneles indiscriminados. Considerar paracetamol a las 4 h o al llegar si han pasado más de 4 h en toda ingesta intencional o incierta.
6. Contactar con SIT/toxicología ante dosis desconocida, formulación retardada, signos clínicos, embarazo, insuficiencia renal/hepática o discrepancia entre historia y evolución.

4.1 Monitorización basal en observación

Parámetro	Frecuencia orientativa	Escalar si
TA, FC, FR, SpO ₂	Ingreso; cada 30 min durante 2 h y después cada 1–2 h si estable	Tendencia desfavorable, SpO ₂ < 94 %, FR < 10 o > 24, hipotensión o taquicardia persistente.
Glasgow y sedación	Ingreso; cada 30 min durante 2 h y después cada 1–2 h	Descenso ≥ 2 puntos, GCS < 13, imposibilidad de proteger vía aérea.
Temperatura	Ingreso y cada 4 h; más frecuente si ISRS o agitación	≥ 38 °C con clonus/rigidez o ascenso progresivo.
ECG 12 derivaciones	Inicial; repetir a 4–6 h o antes si clínica. Esquema intensivo en TCA/citalopram	QRS ≥ 100 ms, QTc ≥ 500 ms, aumento del QTc, arritmia o síncope.
Diuresis y balance	Cada turno; horario si AINE relevante, IR o fluidoterapia	Oliguria, creatinina creciente, vómitos persistentes.

4.2 Descontaminación y tratamiento general

- Carbón activado: no rutinario. Considerar 1 g/kg, máximo habitual 50 g, preferentemente dentro de 1–2 h, solo si dosis potencialmente tóxica y vía aérea protegida; discutir si presentación retardada o gran dosis.
- No inducir el vómito. El lavado gástrico tiene indicaciones excepcionales y debe decidirse con toxicología clínica.
- Corregir hipoglucemia, hipoxia, hipertermia y alteraciones de K, Mg o Ca. Evitar fármacos que prolonguen QT cuando exista riesgo.
- Las pruebas toxicológicas urinarias cualitativas rara vez modifican el manejo y no excluyen ni cuantifican estas intoxicaciones.

5 Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

Incluye fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. La mayoría de las intoxicaciones aisladas son leves; citalopram y escitalopram presentan mayor riesgo de prolongación del QT y arritmias. Las coingestas serotoninérgicas aumentan el riesgo de síndrome serotoninérgico.

Aspecto	Conducta en observación
Clínica diana	Náuseas, vómitos, somnolencia o agitación, temblor, hiperreflexia, clonus, taquicardia, convulsiones y alteraciones QT.
Monitorización	Constantes y Glasgow seriados. ECG inicial en toda ingesta deliberada/relevante. Telemetría en citalopram/escitalopram, síntomas, QTc anormal, bradicardia o coingesta cardiotoxica.
Pruebas	Glucosa; K, Mg, Ca, creatinina y gasometría si síntomas o dosis relevante. CK si hipertermia, rigidez o convulsiones. Paracetamol si exposición intencional/incierta.
ECG seriado	Repetir a 4–6 h en bajo riesgo. En citalopram/escitalopram o QTc alterado: repetir según evolución y antes del alta; mantener hasta normalización/estabilidad.
Observación	Otros ISRS: ≥ 6 h si asintomático, ECG normal y dosis de bajo riesgo. Ampliar a ≥ 12 h si síntomas leves, dosis desconocida/importante, formulación especial o coingesta. Citalopram/escitalopram: ≥ 12 h; 24 h si gran dosis, QTc prolongado, bradicardia, síntomas o riesgo añadido.
Tratamiento	Soporte. Benzodiazepina para agitación, convulsiones o síndrome serotoninérgico leve; enfriamiento externo si hipertermia. Síndrome moderado/grave requiere críticos, sedación intensiva y manejo específico.

Criterios de alta específicos

- Finalizado el periodo individualizado, asintomático, temperatura normal, marcha basal, tolerancia oral y constantes estables.
- ECG normal o sin cambios relevantes, con QRS normal y QTc aceptable/estable; electrolitos corregidos.
- Sin clonus, hiperreflexia progresiva, agitación, convulsiones ni coingesta que requiera más vigilancia.
- Valoración psiquiátrica/psicosocial y plan de seguridad cuando la ingesta sea voluntaria.

6 Antiinflamatorios no esteroideos

Incluye ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno y otros AINE. Verificar siempre si el preparado combina paracetamol, opioides, antihistamínicos o descongestionantes. La toxicidad grave puede producir acidosis, shock, convulsiones y lesión renal.

Aspecto	Conducta en observación
Clínica diana	Dolor epigástrico, náuseas/vómitos, somnolencia, tinnitus, oliguria; en casos graves acidosis, convulsiones, hipotensión y fallo renal.
Monitorización	Constantes y estado mental. Telemetría no rutinaria si la ingesta es aislada, ECG normal y paciente estable; indicarla si alteraciones metabólicas, síntomas graves o coingesta.
Pruebas	Ingesta leve asintomática: pueden no requerirse. Si dosis relevante/síntomas: creatinina, urea, Na, K, bicarbonato, glucosa; gasometría y lactato si grave; hemograma si sangrado. Paracetamol según contexto.
Observación	Liberación inmediata: 4–6 h. Retardada o fármaco de semivida prolongada: ≥ 12 h. Prolongar si vómitos, dolor importante, alteración renal/metabólica, dosis desconocida o coingesta.
Tratamiento	Soporte, antiemético y fluidoterapia prudente si deshidratación. Inhibidor de bomba si clínica gastrointestinal según criterio. Convulsiones con benzodiazepina. No existe antídoto específico.

7 Antidepresivos tricíclicos

Incluye amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina y doxepina. Es el grupo de mayor riesgo del protocolo: una ingesta relevante puede deteriorarse rápidamente. La Unidad de Observación solo es apropiada para vigilancia protocolizada de pacientes inicialmente estables y con acceso inmediato a críticos.

Aspecto	Conducta
Clínica diana	Anticolinérgica, sedación/coma, convulsiones, hipotensión, bloqueo de canales de sodio, QRS ancho, arritmias ventriculares.
Monitorización	Telemetría continua, TA/FR/SpO ₂ frecuentes y vigilancia neurológica estrecha. Material de reanimación disponible.
ECG	Al ingreso y de forma seriada, por ejemplo a 1–2 h y 4–6 h, o inmediatamente ante cambios. Medir QRS, QTc y onda R terminal/eje en aVR.
Pruebas	Glucosa, gasometría, Na, K, Mg, Ca, creatinina; lactato si toxicidad. Paracetamol según contexto. Los niveles séricos de TCA no guían bien la gravedad inmediata.
Observación	Solo alta tras ≥ 6 h desde la ingesta si siempre asintomático y ECG seriado normal. Dosis desconocida, formulación retardada, coingesta o historia no fiable justifican prolongación/consulta.
Bicarbonato sódico	Indicado ante $\text{QRS} \geq 100$ ms, arritmia ventricular, hipotensión atribuible o acidosis: bolos IV de 1–2 mEq/kg, repetidos según respuesta, con objetivo de estrechar QRS y alcalinización controlada (pH aproximado 7,50–7,55). Vigilar Na y K; evitar alcalemia excesiva.
Convulsiones/hipotensión	Benzodiazepinas para convulsiones. Cristaloides prudente; si persiste hipotensión tras bicarbonato y fluidos, noradrenalina suele ser el vasopresor de elección. Consultar toxicología/UCI.

Criterios de traslado o ingreso

- Cualquier síntoma neurológico o cardiovascular, $\text{QRS} \geq 100$ ms, arritmia, hipotensión, convulsión, acidosis o necesidad de bicarbonato excluye el alta tras observación corta.
- Tras toxicidad manifiesta, mantener monitorización en un área de críticos al menos 24 h después de la resolución clínica y electrocardiográfica, individualizando con toxicología/UCI.
- Evitar antiarrítmicos clase IA e IC; evitar fisostigmina en sospecha de TCA. No usar flumazenilo.

8 Benzodiazepinas

La intoxicación aislada suele causar depresión del sistema nervioso central con estabilidad cardiovascular. La gravedad aumenta con opioides, alcohol, antipsicóticos, antidepresivos, edad avanzada, enfermedad respiratoria y preparados de acción prolongada.

Aspecto	Conducta en observación
Monitorización	Glasgow/sedación, FR, SpO ₂ y constantes. Capnografía continua si somnolencia moderada/profunda, hipoventilación, obesidad, EPOC/SAOS o coingesta depresora. Telemetría si coingesta o inestabilidad.
Pruebas	Glucosa. ECG y paracetamol en ingesta intencional/incierta. Gasometría si hipoventilación. Analítica adicional según comorbilidad/coingesta.
Observación	≥ 6 h y hasta recuperación completa. Prolongar 12–24 h si acción larga, edad avanzada, hepatopatía, deterioro persistente, formulación desconocida o coingesta. El alta exige marcha segura y estado basal.
Tratamiento	Soporte de vía aérea y ventilación; posición lateral y prevención de aspiración. No administrar flumazenilo rutinariamente.
Flumazenilo	Reservar para situaciones muy seleccionadas de intoxicación pura en paciente no dependiente y sin riesgo convulsivo, tras consulta experta. Contraindicado si posible TCA/proconvulsivante, dependencia, epilepsia o coingesta desconocida.

9 Pregabalina

La intoxicación aislada suele producir somnolencia, mareo, ataxia, confusión o agitación. Coma y depresión respiratoria son más probables con opioides u otros depresores. La eliminación es renal; la insuficiencia renal puede prolongar la toxicidad.

Aspecto	Conducta en observación
Monitorización	Glasgow/sedación, FR, SpO ₂ y constantes. Capnografía si sedación, hipoventilación, SAOS/EPOC o coingesta depresora. Telemetría solo si clínica, ECG anormal o coingesta.
Pruebas	Glucosa, creatinina y electrolitos si dosis relevante, síntomas o función renal incierta. ECG y paracetamol según contexto. Gasometría si hipoventilación.
Observación	≥ 6 h si aislada, liberación inmediata, asintomático y función renal adecuada. ≥ 12 h si síntomas, gran dosis, hora incierta o coingesta de bajo riesgo. 24 h o ingreso si insuficiencia renal, coma, depresión respiratoria o síntomas persistentes.
Tratamiento	Soporte. Benzodiazepinas si convulsiones o agitación intensa. La naloxona solo trata una posible coingesta opioide; no revierte la pregabalina.
Eliminación extracorpórea	No rutinaria. Considerar discusión con toxicología/nefrólogo en intoxicación grave, especialmente con insuficiencia renal y coma/ventilación prolongada; pregabalina es dializable.

10 Criterios generales de alta

- Periodo de observación completado desde una hora de ingesta razonablemente establecida, o ampliado si esta es incierta.
- Paciente en estado mental y funcional basal, con marcha segura, tolerancia oral, ausencia de vómitos persistentes y constantes estables.
- ECG y analítica final satisfactorios cuando estaban indicados; sin tendencia al deterioro.
- No existe coingesta ni formulación que requiera un tiempo mayor.
- Conciliación de medicación, instrucciones de alarma, acompañante responsable cuando proceda y seguimiento clínico.
- En exposición intencional: evaluación del riesgo suicida, valoración por Salud Mental según circuito local, retirada segura de fármacos y plan de seguridad documentado.

11 Señales de alarma tras el alta

Indicar retorno inmediato ante somnolencia creciente, dificultad respiratoria, síncope, palpitaciones, convulsiones, fiebre, agitación, rigidez o temblor intenso, vómitos persistentes, hematemesis/melena, disminución marcada de diuresis, confusión o cualquier empeoramiento.

12 Hoja de registro para observación

Dato	Registro
Sustancia y presentación	
Dosis máxima posible y peso	
Hora de ingesta Fiabilidad	
Coingestas	
Comorbilidad renal hepática respiratoria cardiaca	
Motivo accidental terapéutico intencional	
SIT toxicología hora y recomendaciones	
Hora de inicio y fin previsto de observación	

Hora	TA	FC	FR	SpO ₂	T	GCS sedación	ECG QTc QRS	Síntomas intervención

Lista de comprobación antes del alta

- ☐ Tiempo mínimo completado ☐ Asintomático y basal ☐ Marcha segura ☐ Tolerancia oral
- ☐ ECG final revisado si indicado ☐ Analítica final revisada si indicada ☐ Sin coingesta de mayor riesgo
- ☐ Valoración de Salud Mental si procede ☐ Acompañamiento/plan de seguridad ☐ Informe e instrucciones de alarma

13 Indicadores de calidad propuestos

Indicador	Definición
ECG precoz en TCA/ISRS de riesgo	Porcentaje con ECG documentado en los primeros 30 min.
Monitorización adecuada	Porcentaje con modalidad y frecuencia acordes al protocolo.
Reevaluación previa al alta	Porcentaje con estado neurológico, constantes y ECG/analítica final documentados.
Valoración de riesgo suicida	Porcentaje de ingestas intencionales con valoración y plan de seguridad.
Reconsulta a 72 h	Reconsultas no planificadas por toxicidad evolutiva.

Bibliografía y fuentes

1. American Heart Association. 2023 American Heart Association focused update on the management of patients with cardiac arrest or life-threatening toxicity due to poisoning. *Circulation*. 2023;148:e149–e184.
2. Thanacoody R, Caravati EM, Troutman B, et al. Position paper update: whole bowel irrigation for gastrointestinal decontamination of overdose patients. *Clin Toxicol*. 2015;53:5–12.
3. Chyka PA, Seger D, Krenzelok EP, Vale JA. Position paper: single-dose activated charcoal. *Clin Toxicol*. 2005;43:61–87.
4. Buckley NA, Whyte IM, Dawson AH, McManus PR, Ferguson NW. Self-poisoning with digoxin and tricyclic antidepressants: predictive value of QRS duration. *Crit Care Med*. 2003;31:1888–1894.
5. Royal Children's Hospital Melbourne. Clinical Practice Guidelines: Selective serotonin re-uptake inhibitors poisoning; Tricyclic antidepressant poisoning; Benzodiazepine poisoning; Nonsteroidal anti-inflammatory drug poisoning. Consultadas en septiembre de 2026. Aunque son pediátricas, se utilizaron como apoyo para principios de vigilancia y se adaptaron al adulto.
6. European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists and American Academy of Clinical Toxicology. Position statements on gastrointestinal decontamination. *Clin Toxicol*.
7. EXTRIP Workgroup. Extracorporeal treatment recommendations for gabapentin and pregabalin poisoning. *Am J Kidney Dis*. 2022;79:88–104.
8. Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Información para profesionales sanitarios y atención telefónica 24 horas: 91 562 04 20.
9. Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, Goldfrank LR, Hoffman RS, eds. *Goldfrank's Toxicologic Emergencies*. 12th ed. McGraw Hill; 2023.
10. Olson KR, ed. *Poisoning and Drug Overdose*. 8th ed. McGraw Hill; 2022.

Nota metodológica: la evidencia para tiempos exactos de observación procede en gran parte de series observacionales, farmacocinética, consensos y práctica de centros toxicológicos. Por ello se han elegido intervalos prudentes y se recomienda validar el protocolo con Farmacia, UCI, Salud Mental, Medicina Preventiva/Calidad y el circuito toxicológico local.